HORA DOS MISERÁVEIS — DOCUMENTO MESTRE DO PROJETO

Programa de Treinamento de Elite para Aprovação no TEOT 2027

Versão 2.0 — Atualizado com Ciclo 2 (Traumatologia)

---

1. Apresentação

O programa HORA DOS MISERÁVEIS é um sistema de treinamento avançado para residentes em ortopedia e traumatologia com finalidade de aprovação no Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) 2027. O método foi desenhado para formar candidatos de elite através de máxima exigência, densidade técnica e foco em performance.

O objetivo não é apenas ensinar. O objetivo é **selecionar, pressionar, expor fragilidades cognitivas, corrigir raciocínios incompletos e formar alunos altamente competitivos**, com desempenho acima da média em provas como TEOT, TARO e avaliações exigentes de residência e título.

---

2. Filosofia do Método

O programa se fundamenta em quatro princípios pedagógicos centrais:

Exigência máxima. Não há questões fáceis no programa. Cada item é calibrado para o nível TEOT/TARO, priorizando integração de conceitos, condutas, classificações, biomecânica, imagem e complicações.

Alto poder discriminativo. Cada questão separa o aluno que "já viu o tema" do aluno que realmente domina o tema. Alternativas plausíveis e verossímeis impedem acertos por reconhecimento superficial.

Densidade técnica. Explicações profundas, sem superficialidade. Correlação com casos clínicos, cenários ambulatoriais, enfermaria, centro cirúrgico e prova oral.

Sofrimento produtivo. O material gera desconforto cognitivo útil, revisão ativa, correção de vícios de raciocínio e consolidação por contraste entre certo e errado.

---

3. Estrutura do Programa

O programa completo compreende 5 ciclos distribuídos em 62 semanas (abril/2026 a novembro/2027), cobrindo 100% do conteúdo programático do TEOT.

Ciclo	Período	Tema	Peso TEOT	Status
1	Meses 1-2 (Sem 1-8)	Ciências Básicas	10-15%	Concluído
2	Meses 3-5 (Sem 9-22)	Traumatologia	35-40%	**Ativo**
3	Meses 6-8 (Sem 23-36)	Ortopedia Clínica	20-25%	Planejado
4	Meses 9-11 (Sem 37-50)	MI + Especialidades	15-20%	Planejado
5	Meses 12-14 (Sem 51-62)	Reta Final	Revisão	Planejado

Carga horária diária recomendada: 5 horas de teoria + 3 horas de questões + flashcards diários.

---

4. Ciclo 2 — Traumatologia (Detalhamento Completo)

O Ciclo 2 é o bloco de maior peso no TEOT (35-40%) e cobre Traumatologia Geral, Membro Superior, Membro Inferior, Pelve/Acetábulo e Coluna Trauma. A análise de provas anteriores revela que fraturas de ossos longos, fraturas expostas e trauma pélvico representam aproximadamente 60% das questões de trauma.

4.1 Padrões de Questões Identificados

Padrão	Frequência	Exemplos
Classificação + conduta direta	50%	Gustilo, Neer, Schatzker, Tile, Young-Burgess
“Conduta mais adequada”	30%	Timing desbridamento, DHS vs Gamma, fasciotomia
“Complicação mais comum”	20%	Infecção pós-IIIB, dor ombro pós-IM, AVN acetábulo

4.2 Roteiro Semanal

Semanas	Tema	Conteúdo
9-11	Trauma Geral	Expostas (Gustilo), compartimental, infecção, embolia, TVP, damage control
12-14	Membro Superior	Úmero (Neer), diáfise (n. radial), Monteggia/Galeazzi, cotovelo (Gartland, Essex-Lopresti, PLRI)
15-17	Membro Inferior	Fêmur (Garden/Pauwels), tíbia (haste IM), joelho periarticular (Schatzker, patela)
18-20	Pelve/Acetábulo + Coluna	Tile, Young-Burgess, Judet-Letournel, odontoide, hangman, TLICS, Chance
21-22	Integração e Revisão	Simulado completo, flashcards, casos integrados de polytrauma

4.3 Material Produzido

O Ciclo 2 conta com 80 questões comentadas (40 originais + 40 novas com enfoques especiais), 12 vídeos técnicos de 50-70 minutos cada, e simulados por bloco temático. As questões novas variam os enfoques tradicionais, incorporando cenários pediátricos, pacientes osteoporóticos, gestantes politraumatizadas, pacientes com metástases ósseas e situações de polytrauma complexo.

4.4 Vídeos do Ciclo 2

Vídeo	Título	Duração	Fonte
9	Trauma Geral I — Fraturas Expostas	60 min	Rockwood, Cap. 12-13
10	Trauma Geral II — Síndrome Compartimental	55 min	Browner, Cap. 10-11
11	Trauma MS I — Úmero Proximal e Diafisário	65 min	Rockwood, Cap. 33-35
12	Trauma MS II — Rádio/Ulna, Monteggia e Galeazzi	60 min	Campbell's, Cap. 57-58
13	Trauma MS III — Cotovelo e Antebraço	55 min	Rockwood, Cap. 36-39
14	Trauma MI I — Fêmur Proximal e Diafisário	70 min	Browner, Cap. 48-52
15	Trauma MI II — Tíbia e Perna	65 min	Rockwood, Cap. 53-55
16	Trauma MI III — Joelho Periarticular	60 min	Campbell's, Cap. 54-55
17	Pelve I — Anel Pélvico	55 min	Browner, Cap. 37-39
18	Pelve II — Acetábulo	65 min	Rockwood, Cap. 41-43
19	Trauma Coluna I — Cérvico-Torácica	60 min	Rockwood, Cap. 28-31
20	Trauma Coluna II + Integração	70 min	Browner, Cap. 25-27, 60-62

---

5. Estrutura das Questões

Cada questão do programa segue uma estrutura obrigatória que garante profundidade técnica e poder discriminativo:

1. Tema principal e subtema
2. Nível de dificuldade (Alto / Muito Alto / Brutal-Elitizado)
3. Objetivo cognitivo (reconhecimento, integração, conduta, complicação, etc.)
4. Enunciado robusto com caso clínico
5. 4 alternativas plausíveis (A-D)

6. Gabarito
7. Comentário técnico detalhado
8. Justificativa de cada alternativa
9. Pérola de prova
10. Armadilha clássica
11. Correlação prática (ambulatório, CC, emergência, enfermaria)
12. Referência-base (Rockwood, Browner, Campbell's)

---

6. Níveis de Dificuldade

Nível 1 — Alto. Exige conhecimento sólido. Cobra definição, conduta, classificação ou conceito bem conhecido, mas com pegadinha leve.

Nível 2 — Muito Alto. Exige integração de múltiplos conceitos. Alternativas muito próximas. Leitura fina e raciocínio clínico bem estruturado.

Nível 3 — Brutal/Elitizado. Questão para separar a elite. Exige associação entre imagem, clínica, biomecânica, complicação, indicação e prova. Erro de interpretação mínima leva à alternativa errada.

---

7. Referências Bibliográficas

1. Rockwood CA, Green DP, Bucholz RW. Rockwood and Green's Fractures in Adults. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2019.
2. Browner BD, Jupiter JB, Krettek C, Anderson PA. Skeletal Trauma: Basic Science, Management, and Reconstruction. 6th Edition. Elsevier, 2019.
3. Azar FM, Beaty JH, Canale ST. Campbell's Operative Orthopaedics. 14th Edition. Elsevier, 2020.
4. Rockwood CA, Wilkins KE. Rockwood and Wilkins' Fractures in Children. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2019.
5. Vaccaro AR, et al. AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System (TLICS). Spine, 2005.

6. Gustilo RB, Anderson JT. Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones. JBJS, 1976.
7. Tile M. Fractures of the Pelvis and Acetabulum. 4th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2015.